

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức — Nam

Thông tin cho bệnh nhân · Tiểu són sau phẫu thuật tuyến tiền liệt — khi gắng sức hoặc vận động

WARWIKI

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức (SUI) ở nam giới nghĩa là rò rỉ nước tiểu khi có áp lực đột ngột lên bàng quang — ho, đứng dậy, nâng vật nặng hoặc vận động. Ở nam giới, nguyên nhân hầu hết là do cơ kiểm soát tiểu (cơ thắt) bị suy yếu sau **phẫu thuật tuyến tiền liệt** hoặc xạ trị. Tình trạng này thường cải thiện trong năm đầu, và nếu không cải thiện, vẫn có các phương pháp điều trị rất hiệu quả.

Về tình trạng này

Sau khi cắt bỏ tuyến tiền liệt, **cơ thắt niệu đạo** (van giữ nước tiểu) phải gánh thêm trách nhiệm và có thể bị suy yếu. Kết quả là rò rỉ khi gắng sức — từ vài giọt cần miếng lót, đến rò rỉ nhiều hơn. Đây khác với tiểu **gấp** (buồn tiểu đột ngột), được điều trị khác; một số nam giới có cả hai.

Nguyên nhân

- **Cắt tuyến tiền liệt tận gốc** (lấy tuyến tiền liệt do ung thư) — nguyên nhân phổ biến nhất
- Các thủ thuật tuyến tiền liệt khác hoặc **xạ trị vùng chậu**
- Ít gặp hơn: bệnh lý thần kinh hoặc bàng quang

Rò rỉ thường **nặng nhất lúc đầu** và cải thiện dần trong vài tuần đến vài tháng khi vết thương lành và sức cơ sàn chậu phục hồi.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Rò rỉ nước tiểu khi có áp lực — ho, đứng, nâng vật.

Cơ thắt

Van cơ giữ nước tiểu cho đến khi bạn muốn đi tiểu.

Cắt tuyến tiền liệt

Phẫu thuật lấy tuyến tiền liệt, nguyên nhân thường gặp của SUI nam.

Sàn chậu

Các cơ được tập luyện để kiểm soát tiểu tiện.

Kiểm tra miếng lót

Đếm số miếng lót mỗi ngày để đo lường rò rỉ.

Băng nâng nam

Dây đỡ đặt dưới niệu đạo cho rò rỉ mức độ nhẹ—vừa.

Bóng ProACT

Hai bóng điều chỉnh được đặt cạnh niệu đạo, hiệu chỉnh tại phòng khám; lựa chọn ít xâm lấn.

Cơ thắt niệu đạo nhân tạo (AUS)

Thiết bị cấy ghép (vòng bít bạn điều khiển) cho rò rỉ mức độ vừa—nặng.

CÓ TỰ CẢI THIỆN KHÔNG? Thường là có — rò rỉ sau phẫu thuật tuyến tiền liệt thường cải thiện trong 6–12 tháng đầu, đặc biệt khi tập bài tập cơ sàn chậu. Nếu rò rỉ còn gây phiền toái sau khoảng một năm, đó là thời điểm cân nhắc băng nâng, bóng điều chỉnh, hoặc cơ thắt nhân tạo — tất cả đều rất hiệu quả.

Chẩn đoán như thế nào

- Hỏi về thời điểm và mức độ rò rỉ (thường tính theo **số miếng lót mỗi ngày**)
- **Xét nghiệm nước tiểu** và kiểm tra khả năng làm rỗng bàng quang
- Trước phẫu thuật: nội soi niệu đạo (cystoscopy) và đôi khi kiểm tra chức năng bàng quang

Điều trị như thế nào (Từng bước)

- 1 Bài tập cơ sàn chậu (Kegel)**, lý tưởng nhất là bắt đầu quanh thời điểm phẫu thuật, kết hợp kiểm soát lượng nước uống và cân nặng.
- 2 Theo dõi sự cải thiện** trong năm đầu, dùng miếng lót/bảo vệ khi cần.
- 3 Băng nâng nam** — cho rò rỉ nhẹ đến vừa kéo dài (không có mô sẹo sau phẫu thuật).
- 4 Bóng ProACT điều chỉnh được** — lựa chọn ít xâm lấn khác cho rò rỉ nhẹ đến vừa; hai bóng nhỏ được hiệu chỉnh tại phòng khám qua nhiều lần hẹn (không dùng sau xạ trị).
- 5 Cơ thắt niệu đạo nhân tạo (AUS)** — tiêu chuẩn vàng cho rò rỉ vừa đến nặng, và là lựa chọn sau xạ trị. Mỗi loại có tờ thông tin riêng.

Sống chung với SUI nam

- Tập bài tập cơ sàn chậu đều đặn — đây là nền tảng.
- Dùng miếng lót hoặc đồ bảo vệ để tự tin trong khi hồi phục.
- Hạn chế uống nhiều vào buổi tối và tránh caffeine nếu rò rỉ ban đêm là vấn đề.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Đau rát, sốt, hoặc **tiểu ra máu** (có thể nhiễm trùng)
- Đột ngột **không thể đi tiểu**
- Rò rỉ ngày càng tệ hơn thay vì cải thiện

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- 1.** SUI nam hầu hết do cơ thắt suy yếu sau phẫu thuật hoặc xạ trị tuyến tiền liệt — và thường cải thiện trong năm đầu.
- 2.** Bài tập cơ sàn chậu là nền tảng; nếu rò rỉ kéo dài, băng nâng nam hoặc cơ thắt niệu đạo nhân tạo rất hiệu quả.
- 3.** Chờ hồi phục đến một năm trước khi quyết định phẫu thuật. Gọi ngay nếu có sốt, tiểu ra máu, hoặc không tiểu được.